

Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)

Durée : 45 minutes

Niveau : Intermédiaire (Étudiants en médecine, Internes, Médecins généralistes)

Mots-clés : Rhumatisme Articulaire Aigu, RAA, Streptocoque du groupe A, Cardite rhumatismale, Chorée de Sydenham, Polyarthrite, Critères de Jones, Pénicilline, Prophylaxie

Objectifs Pédagogiques

- Définir le RAA comme une complication post-infectieuse d'une angine à streptocoque A.
- Décrire la physiopathologie du mimétisme moléculaire.
- Identifier les manifestations cliniques en utilisant les critères de Jones révisés.
- Souligner le rôle de l'atteinte cardiaque (cardite) qui conditionne le pronostic.
- Prescrire les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic.
- Planifier la prise en charge de la poussée aiguë (traitement anti-infectieux et anti-inflammatoire).
- Expliquer l'importance capitale et les modalités de la prophylaxie secondaire pour prévenir les récives.

Introduction et Contexte Scientifique

Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une maladie inflammatoire systémique, non suppurative, qui survient comme une complication retardée d'une pharyngite non ou mal traitée à Streptocoque β -hémolytique du groupe A. Il ne complique JAMAIS les infections cutanées à streptocoque. Touchant principalement les enfants et adolescents de 5 à 15 ans dans les pays en développement, sa gravité réside dans le risque d'atteinte cardiaque (cardite), qui peut évoluer vers une cardiopathie rhumatismale chronique, principale cause de cardiopathie acquise de l'enfant dans le monde. Le diagnostic repose sur les critères de Jones, associant des manifestations majeures (cardite, polyarthrite, chorée, érythème marginé, nodules sous-cutanés) et mineures. La prise en charge repose sur l'éradication du streptocoque, un traitement anti-inflammatoire et, surtout, une prophylaxie secondaire prolongée par la Pénicilline pour prévenir les récives et l'aggravation des lésions cardiaques.

Contexte et épidémiologie

Définition:

Le RAA est une complication inflammatoire systémique retardée d'une angine à Streptocoque β -hémolytique du groupe A (SGA). C'est une maladie auto-immune et non une infection des organes touchés.

Agent Causal:

- Infection pharyngée (angine) par une souche de Streptococcus pyogenes (SGA).
- Important : Seules les angines sont 'rhumatogènes'. Les infections cutanées à SGA (impétigo) ne provoquent PAS de RAA.

Intervalle Libre:

Il existe un délai caractéristique de 2 à 4 semaines entre l'angine (souvent passée inaperçue) et le début des symptômes du RAA.

Épidémiologie:

- Maladie des pays en développement, associée à la promiscuité, la pauvreté et un accès limité aux soins.
- Âge: Pic d'incidence entre 5 et 15 ans.
- Son incidence a drastiquement chuté dans les pays industrialisés grâce à l'antibiothérapie systématique des angines streptococciques.

Physiopathologie

Le mécanisme principal est le mimétisme moléculaire, une réaction d'hypersensibilité de type II.

1. Infection Pharyngée: Le patient est infecté par une souche de SGA.
2. Réponse Immunitaire: L'organisme produit des anticorps contre les antigènes du streptocoque, notamment la protéine M de sa paroi.
3. Réaction Croisée: Par ressemblance structurale, ces anticorps anti-streptococciques reconnaissent et attaquent par erreur des tissus de l'hôte (auto-antigènes).
 - Tissus cardiaques (myosine, glycoprotéines valvulaires) → Cardite.
 - Neurones des noyaux gris centraux (ganglions de la base) → Chorée de Sydenham.
 - Synoviale articulaire → Arthrite.
 - Tissus sous-cutanés → Nodules.

Ce processus déclenche une cascade inflammatoire systémique dans les organes cibles. La prédisposition génétique joue également un rôle important.

Tableau clinique et Critères de Jones

Le diagnostic est clinique et repose sur les critères de Jones (révisés en 2015). Il faut une PREUVE D'INFECTION STREPTOCOCCIQUE RÉCENTE + 2 critères majeurs OU 1 critère majeur et 2 critères mineurs.

Critères Majeurs ('J ♥ NES'):

1. Joints (Polyarthrite): C'est la manifestation la plus fréquente. Typiquement une polyarthrite migratoire et fugace des grosses articulations (genoux, chevilles, coudes, poignets). Elle est asymétrique, très douloureuse, et répond de façon spectaculaire aux salicylés (aspirine).
2. ♥ (Cardite): C'est le critère de gravité. Elle conditionne tout le pronostic. Il s'agit d'une pancardite (atteinte des 3 tuniques du cœur).
 - Endocardite (valvulite): Constante et la plus importante. Touche surtout la valve mitrale (insuffisance mitrale) puis aortique (insuffisance aortique). Se traduit par l'apparition d'un souffle cardiaque.
 - Myocardite: Tachycardie, assourdissement des bruits du cœur, signes d'insuffisance cardiaque.
 - Péricardite: Douleurs thoraciques, frottement péricardique.
3. Nodules sous-cutanés (de Meynet): Rares mais spécifiques. Fermes, indolores, mobiles, situés sur les faces d'extension des articulations (coudes, genoux).
4. Érythème marginé: Rare. Éruption cutanée non prurigineuse, rosée, avec des bords nets et un centre clair, siégeant sur le tronc.
5. Sydenham (Chorée de): Manifestation tardive (1 à 6 mois après l'angine). Mouvements involontaires, anarchiques et rapides, labilité émotionnelle, hypotonie musculaire. Peut être le seul signe de RAA.

Critères Mineurs:

- Arthralgies (ne compte pas si l'arthrite est un critère majeur).

- Fièvre ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$).
- Élévation des marqueurs de l'inflammation: VS (>60 mm) ou CRP (>30 mg/L).
- Allongement de l'espace PR sur l'ECG (ne compte pas si la cardite est un critère majeur).

Examens complémentaires

A. Preuve d'une infection à SGA (Obligatoire)

- Titres d'anticorps anti-streptococciques: ASLO (Anti-Streptolysine O) et/ou Anti-DNase B élevés. Le prélèvement de gorge est souvent négatif au stade de RAA.

B. Marqueurs de l'inflammation

- Vitesse de sédimentation (VS) et Protéine C-réactive (CRP) sont très élevées et utiles pour le suivi de l'efficacité du traitement.

C. Bilan Cardiaque

- Électrocardiogramme (ECG): Recherche un bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré (allongement de PR), des signes de péricardite ou de myocardite.
- Échocardiographie Doppler: Examen CLÉ. Systématique, même en l'absence de souffle. Confirme la cardite, détecte les valvulopathies (fuites mitrale et aortique), évalue la fonction ventriculaire et la présence d'un épanchement péricardique. Permet de détecter les cardites infracliniques.

Diagnostic différentiel

Dépend de la manifestation prédominante :

- Devant une polyarthrite fébrile: Arthrite juvénile idiopathique, arthrite réactionnelle, arthrite septique, lupus, leucémie aiguë.
- Devant une cardite: Myocardite virale, endocardite infectieuse, maladie de Kawasaki.
- Devant une chorée: Lupus érythémateux disséminé, causes médicamenteuses, maladie de Wilson.

Prise en charge

L'hospitalisation est la règle. Le traitement vise 3 objectifs : éradiquer le SGA, contrôler l'inflammation, et prévenir les récurrences.

1. Traitement anti-infectieux:

- But: Éradiquer tout foyer de SGA résiduel.
- Systématique, même si le prélèvement de gorge est négatif.
- Pénicilline G Benzathine (Extencilline®): 1,2 M UI en une injection IM unique (600 000 UI si < 27 kg).

2. Traitement anti-inflammatoire:

- Le choix dépend de la sévérité.
- Arthrite isolée: Aspirine à fortes doses (80-100 mg/kg/j). La réponse est souvent spectaculaire en 24-48h.
- Cardite légère à modérée (sans insuffisance cardiaque): Aspirine seule.
- Cardite sévère (avec insuffisance cardiaque ou cardiomégalie): Corticothérapie (Prednisone 2 mg/kg/j) pour 2-3 semaines, puis relais par l'aspirine.

3. Repos:

- Repos au lit strict, dont la durée est adaptée à la sévérité de la cardite, jusqu'à normalisation du syndrome inflammatoire.

4. Traitement de l'insuffisance cardiaque si présente (diurétiques, IEC).

Prévention et Prophylaxie

C'est la partie la plus importante pour le pronostic à long terme.

A. Prévention Primaire

- But: Empêcher la survenue du premier épisode de RAA.
- Moyen: Traitement correct de toute angine à SGA documentée par une antibiothérapie de 10 jours (Amoxicilline).

B. Prévention Secondaire (Prophylaxie)

- But: Empêcher les récurrences de RAA chez un patient ayant déjà fait un épisode. Chaque récurrence aggrave le risque de lésions cardiaques définitives.
- Moyen: Antibiothérapie continue au long cours.
- Molécule de choix: Pénicilline G Benzathine (Extencilline®) 1,2 M UI en IM toutes les 3 à 4 semaines.
- Durée de la prophylaxie (recommandations OMS/AHA) :
- RAA sans cardite: 5 ans après la dernière poussée ou jusqu'à l'âge de 21 ans (la durée la plus longue étant retenue).
- RAA avec cardite guérie (sans séquelle valvulaire): 10 ans après la dernière poussée ou jusqu'à l'âge de 21 ans (la plus longue).
- RAA avec cardite et séquelle valvulaire persistante: 10 ans après la dernière poussée ou jusqu'à l'âge de 40 ans (la plus longue), parfois à vie.

L'observance de cette prophylaxie est cruciale.

Résumé final

Le RAA est une complication immunologique d'une angine à streptocoque A. Son diagnostic repose sur les critères de Jones, qui associent des signes articulaires, cardiaques, neurologiques et cutanés. La gravité est entièrement liée à la cardite, qui peut laisser des séquelles valvulaires définitives (cardiopathie rhumatismale). Le traitement de la crise aiguë combine Pénicilline et anti-inflammatoires. Cependant, la pierre angulaire de la prise en charge est la prophylaxie secondaire par Pénicilline au long cours, seul moyen efficace de prévenir les récurrences et de préserver l'avenir cardiaque des patients.

Références Bibliographiques

1. Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(20):1806-18.
2. Carapetis JR, Beaton A, Cunningham MW, et al. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:15084.
3. World Health Organization. Rheumatic fever and rheumatic heart disease. Report of a WHO Expert Consultation. WHO Technical Report Series, No. 923. Geneva: 2004.
4. Pédiatrie. 3e édition. Ed. Elsevier Masson. Collège National des Pédiatres Universitaires.